EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67825
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2023-07-22 12:36:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS HUMBERTO MUN?OZ NAVARRETE			RUN	: 4.847.742-9
F.Nac	: 18-03-2023	Edad	: 0 AÑO, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-06-27	Fecha Egreso	: 2023-07-22 12:36:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV isquémico tálamo-capsular derecho, obs 2° a ATE intracraneano (ateroma V4 derecho)
-Calcificaciones venas cerebrales medulares internas y pulvinar bilateral en evaluación, obs sd Fabry inicio tardio
-Sd febril sin foco resuelto
-Sd diarreico resuelto
-Obs crisis convulsiva sintomática

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PTE MASCULINO DE 80 AÑOS DIESTRO, AUTOVALENTE, CON USO DE ANDADOR, VIVE SOLO, ANTECEDENTE DE SX LACUNAR TRANSITORIO EN MARZO 2023 ULTIMA VEZ VISTO BIEN JUEVES NOCHE 22/6 ES ENCONTRADO L DIA VIERNES EN HORAS DE L AMAÑANA POR FAMILIAR EN EL SUELO DE SU DORMITORIO CON ALTERACION DEL ESTADO DE CONCIENCIA , DIFICULTAD PARA ARTICULAR PALABRAS Y DEFICIT MOTOR EN HEMICUERPO IZQUIERDO, POR LO CUAL ES TRASLADADO A SU HSC DONDE INGRESA, SE EVALUA Y SE SOLICITA ANGIOTAC DE CEREBRO Y CUELLO CON HALLAZGOS DE CALCIFICACIONES EN NUCLEOS BASALES, TALAMOCAPSULAR Y CEREBELO, SIN IMAGENES HIPO NI HIPERDENSAS QUE SUGIERAN LESION VASCULAR AGUDA; CON ESTENOSIS PROXIMAL DE V4 DERECHA Y P1 ACPDERECHA . SE REALIZA PUNCION LUMBAR PARA ESTUDIO DE LCR CON CITOQUIMICO NO PATOLOGICO CON CULTIVO PENDIENTE. ANTECEDENTES PERSONALESAntecedentes: - Diabetes mellitus tipo 2 IR - Hipertensión arterial - Dislipidemia - Poliartrosis - HPB Antecedentes quirúrgicos: - Apendicectomia - Orquiectomia derecha Alergias: - Sin antecedentes de alergia a medicamentos Medicamentos: - Insulina NPH 10UAM - 6 UPM - Aspirina 100 mg, 1 comp al día - Gemfibrozilo 600 mg al día Hábitos: - Tabaco (-) - OH (-) SE RECIBE HOY EN SALA SOMNOLIENTO, HDN ESTABLE, CON RITMO SINUSAL EN MONITOR. PA: 133/81MMHG PAM: 82MMHG FC: 89X´FR: 20X´SATO2 94% EX. NEUROLOGICO: SOMNOLIENTO, LENGUAJE ESCASO Y DIARTRICO, ORIENTACION NO EVALUABLE, PFC LEVE IZQ, PUPILAS ISORICAS NORMOREACTIVAS CON DESVIACION DE LA MIRADA CONJUGADA A LA DERECHA, CON ESTIGMA DE MORDEDURA EN LENGUA (HEMATOMA) HEMIPARESIA IZQUIERDA BRAQUIAL MO , CRURAL M3, CUTANEO PLANTAR EXTENSOR BILATERAL, SIN TROMMER, FUNCIONES CEREBEOLOSAS NO VALORABLES, SIN RIGIDEZ DE NUCA NI SIGNOS MENINGEOS
PL resultó no inflamatoria, cultivo LCR, HC y urocultivo iniciales negativos a la fecha, exs de lab destaca fx renal N, Na 145, PCR leve aumento respecto a ingreso (5->17), leucocitosis en descenso, impresiona no haber un cuadro infeccioso en evolución, no se objetiva un foco al ex fco ni imagenológico, hematuria en OC podría corresponder a HPB basal.
TC torax sin lesiones agudas.
TC cerebro s/c de ayer muestra infarto talamocapsular derecho sin TH (insinuado en TC de ingreso),

en angioTC cerebro y cuello se observa ateroma/trombo mural V4 derecha (mismo hallazgo que en angioTC de marzo/23) y ACP derecha fetal.
Respecto a hallazgos en parenquima (calcificaciones de venas medulares internas supratentoriales y pontinas, hiperintensidad pulvinar y cortical occipital polar y mesial bilaterales simétricas) sin cambios respecto a TC de marzo/23.
En estudio reumatologico y metabolismo fosfocalcico y de hierro destaca ferritina alta (que podría ser 2° a inflamación) y ANA 1/80, resto negativo o normal.
Cuadro podria corresponder a una enf Fabry de inicio tardío o una vasculopatía inflamatoria de pequeño vaso (sin ANCA en ex previo) por tener 2
angioTC cerebro y cuello normales; no es descartable presencia de enf Wernicke o que todo sea 2° a una enfermedad de pequeño vaso ateroesclerótica por FRCV no controlados. Al ingreso se inició LVT por sospecha de comicialidad en vista de TC inicial normal y hemiparesia que podría corresponder a sd Todd, mantengo (y aumento) FAE por presencia de hiperintensidad cortical occipital que podría ser epileptogénica.
Mantengo DAPT por presencia de enf ateromatosa intracraneana VB.

Evolución
Paciente en REG, HDN estable con tendencia a la hipoTA, eupneico, afebril, RS al monitor, hiperglicemia en control casi completo, estable en déficit neurológico y nivel de conciencia, no refiere molestias, tolera bien alimentación por SNG.
Pendiente estudio enf Fabry. Jefe de laboratorio informa sin licitación para INTA. Se realizará compra de estudio mutación en red UC.
Completó tto ATB por diarrea y sf infeccioso febril sin foco, con regresión completa de parametros inflamatorios, y mejoría clínica. A pesar de 2 panTC y multiples series de cultivos no se aisló germen.
No se detectaron lesiones tumorales en estudio por EDA, colonoscopia y TC.
RM cerebro c/c mostró hiperintensidad de pulvinares, sugerentes de enf Fabry, sin lesiones que sugieran otra patología.
Exs lab previo a alta destaca procalcitonina 0.16, PCR 6
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio el 22/7/23
y control ambulatorio en policlínico de Neurolgía. Se mantiene alimentación por SNG en domicilio por riesgo de aspiración en contexto de nivel de conciencia fluctuante.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio el 22/7/23
-Control en policlínico de Neurología en 10-12 días
-Mantener DAPT (aspirina y clopidogrel)
-IC HODOM para continuar rehabilitacion kinésica y fonoaudiológica

INDICACIONES AL ALTA

1. -Ipratropio 2 puff c/8h SOS, c/aerocámara
2. -Levetiracetam (500 mg) 1/2 comp c/12h
3. -Atorvastatina (40 mg) 1 comp/noche
4. -Aspirina 100 mg/d
5. -Clopidogrel 75 mg/d
6. -Famotidina 40 mg/d
7. -Insulina 26 U AM - 10 U PM

EXÁMENES Y RESULTADOS

21/7/23
-PCR 6
-Procal 0.16

20/7/23
-Crea 0.5 MDRD 159.99 Uremia 20
-Na 138 K 4.5 Cl 101
-Leu 13500 Hb 12.9 Plaq 536000 Seg 68 VHS 48
-Procal 0.33

19/7/23
-Crea 0.4 MDRD 206.98 Uremia 18
-Na 138 K 4.1 Cl 106
-Leu 15400 Hb 12.8 Plaq 462000 Seg 61 VHS 30
-Procal 0.54

18/7/23
-Crea 0.6 MDRD 129.64 Uremia 15
-Na 138 K 4.3 Cl 100
-Leu 13600 Hb 13.1 Plaq 450000 Seg 65 VHS 38
-Procal 1.34

17/7/23
-Crea 0.6 MDRD 129.64 Uremia 14
-Ca 9.2 Na 139 K 4.1 Cl 105
-FA 82 BI 0.63 BD 0.07 BT 0.7 GOT 37 GPT 47 GGT 41
-LDH 236
-Lact 1.2
-Leu 18200 Hb 12.8 Plaq 395000 Seg 77 VHS 20
-INR 1.14 TTPA 26
-Procal 3.16

15/7/23
-Crea 0.7 MDRD 108.51 uremia 25
-Ca 8.7 Na 140 K 3.9 Cl 107
-FA 86 BI 0.5 BD 0.1 BT 0.6 GOT 44 GPT 48 GGT 36
-LDH 185
-Lact 1
-Leu 13200 Hb 11.4 Plaq 341000 Seg 69 VHS 38
-INR 1.12 TTPA 27
-Procal 15.9

14/7/23 2° examen
-Leu 19700 Hb 11.7 Plaq 348000 Seg 83 VHS 36
-Procal 21.7114/7/23 1° examen
-Crea 0.7 MDRD 108.51 Uremia 25
-Na 139 K 4 Cl 106
-Leu 24100 Hb 11.7 Plaq 336000 Seg 82 Bacil 1 VHS 40
-Procal 20.44

13/7/23
-Crea 0.6 MDRD 129.64 Uremia 28
-AU 0.8
-Ca 8.5 Na 142 K 3.7 Cl 107
-FA 80 BI 0.89 BD 0.01 BT 0.9 GOT 25 GPT 32 GGT 22
-CKMB 16 CK 75
-LDH 188
-Lact 1
-Leu 14500 Hb 11.5 Plaq 320000 Seg 70 VHS 39
-INR 1.27
-Procal 0.04
-CD(-)

12/7/23
-Crea 0.6 MDRD 129.64 Uremia 38
-Na 142 K 3.3 Cl 108
-PCR sin reactivo
-Leu 16000 Hb 11.4 Plaq 346000 Seg 76 VHS 36
-Procal 0.19

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+), estertores escasos, disfonía leve
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas, TR N, genitales N, PP(-)
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurologico:
-Mental: vigil, confusión leve, parcialmente OTE, lenguaje fluente, nomina 5/5, repite frases complejas, comprende órdenes de 4 pasos cruzando linea media
-PC: CV por amenaza impresiona conservado, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC izq leve, sens facial tactil N, nistagmo(-),
úvula y lengua centrales, fuerza ECM M5 bilateral
-Motor: BC derecho M4-5, ESI M2 (al dolor), EII M3, RCP extensor bilateral
-Sensitivo: sensibilidad tactil y algésica impresiona conservada
-Cerebelo: impresiona conservado a pesar de paresia y confusión leve
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO